

**PROTOCOLO DE ACESSO
À ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO SONO E EXAME DE
POLISSONOGRAFIA**

Versão 1.0 – 2026





MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



PREFEITA

Rejane Gambin

SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE GESTÃO JURÍDICA E ORGANIZACIONAL

Marcianita Lopata de Lima

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE

Sheila Batista de Araújo

DIRETORIA DE VIGILÂNCIAS

Maria Cristina Antunes Willemann

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Leste

Grasiela Florencio Medeiros – Distrito Norte

Gislaine Batista de Souza – Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado



GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nádia Cristina Brach

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski Borges

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

REVISÃO

Andre Salfer Maciel

Paulo Issao Kanashiro

Thais Camile Bauer de Oliveira

ELABORAÇÃO

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

Fabiane Voss



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	8
2.INFORMAÇÕES REFERENTE A ESPECIALIDADE DA MEDICINA DO SONO.....	10
2.1 Objetivos clínicos e diagnósticos.....	10
2.2 Indicações clínicas e critérios de acesso.....	10
2.3 Profissionais requisitantes.....	10
2.4 Requisitos mínimos para o encaminhamento.....	11
2.5 Matriz de estratificação de risco para medicina do sono.....	11
3.INFORMAÇÕES REFERENTE AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA.....	13
3.1 Objetivos Clínicos e Diagnósticos.....	13
3.2 Critérios de emergência.....	13
3.3 Indicações clínicas e critérios de acesso.....	13
3.4 Profissionais requisitantes.....	14
3.5 Requisitos mínimos para o encaminhamento.....	14
3.6 Matriz de estratificação de risco para exame de polissonografia.....	15
REFERÊNCIAS.....	16
ANEXO A - STOP-BANG.....	17



LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Tabela de conferência para encaminhamento para medicina do sono (checklist obrigatório).....	11
Tabela 02 - Matriz de estratificação de risco para medicina do sono.....	11
Tabela 03 - Tabela de conferência para encaminhamento para exame de polissonografia (checklist obrigatório).....	14
Tabela 04 - Matriz de estratificação de risco para medicina do sono.....	15



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

APS – Atenção Primária à Saúde

CPAP - Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas

IMC – Índice de Massa Corporal

NGQP - Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos

O2 - Oxigênio

RAS - Redes de Atenção à Saúde

SAOS - Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono

SES/SC - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

SISREG - Sistema Nacional de Regulação



1.INTRODUÇÃO

Os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 196, que assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado. A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 15.126/2025) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a organização e funcionamento dos serviços de saúde no país.

A regulação assistencial, ou regulação do acesso, consiste na disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma ordenada, oportuna, qualificada e equânime, sendo um instrumento fundamental para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Por meio do processo regulatório, promove-se a resolução de casos que exigem ações articuladas em diferentes pontos de atenção, favorecendo a gestão racional dos recursos, a identificação de áreas críticas e a otimização do atendimento.

Visto que os protocolos de acesso são instrumentos de ordenação dos fluxos de encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente, orientando quanto à competência dos níveis de atenção.

É imperativo que a adequada organização e otimização do acesso aos exames especializados contribuam para protocolos mais claros e intuitivos para os profissionais de saúde, além de melhorar o direcionamento às reais necessidades dos pacientes.

Portanto, houve a necessidade de organização do encaminhamento de pacientes portadores de Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS), para a especialidade Medicina do Sono, via Sistema de Regulação do Estado - SISREG.

A SAOS é um distúrbio respiratório mais frequente durante o sono, caracterizado por episódios repetidos de obstrução total (apnéia) ou parcial (hipopnéia) das vias aéreas superiores. Essa condição leva a dessaturação da oxihemoglobina intermitente, microdespertares e fragmentação do sono (DUARTE et al, 2022).

Essa patologia está comumente associada a consequências cardiovasculares, metabólicas e neurocognitivas, ocasionando diminuição importante da qualidade de vida, além de impactar na mortalidade. Quando não tratada, a SAOS representa risco à saúde, com custos econômicos que afetam o indivíduo, a família e a sociedade (HUYETT E BHATTACHARYYA, 2021; DUARTE et al, 2022).

É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, índice de massa corporal, presença ou não de doenças associadas e medicações em uso. Bem

como aplicar o questionário STOP-Bang (ANEXO I). Destaca-se que essas atribuições fazem parte da avaliação realizada pelo médico da Atenção Primária de Saúde (APS) para subsidiar a indicação de cada usuário quanto a necessidade do encaminhamento para realização do exame de polissonografia que será utilizado para determinar a prioridade do usuário em relação ao tempo de espera para chegar até a avaliação com a especialidade medicina do sono.

A Secretaria de Saúde do município de Joinville, adota os mesmos critérios utilizados pelo protocolo do estado de Santa Catarina, para realização da Polissonografia e para especialidade da Medicina do Sono.

Logo, este protocolo visa nortear a tomada de decisão dos médicos reguladores, fomentando uma cultura onde o encaminhamento à Atenção Especializada ocorra estritamente por critérios de necessidade clínica. Este fluxo pressupõe que a APS tenha exaurido sua capacidade resolutiva para o caso, contudo, sem transferir sua responsabilidade técnica: a APS permanece como a coordenadora do cuidado e o centro ordenador da rede, garantindo o acompanhamento longitudinal e a continuidade da assistência ao usuário após a realização do procedimento especializado.



2. INFORMAÇÕES REFERENTE A ESPECIALIDADE DA MEDICINA DO SONO

A Medicina do Sono é uma especialidade médica e área de atuação científica dedicada ao estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção dos distúrbios do sono e das patologias relacionadas ao ciclo sono-vigília. Ela reconhece o sono como um processo ativo e fisiológico, fundamental para a saúde física, cognitiva e metabólica, e não apenas um estado passivo de repouso.

2.1 Objetivos clínicos e diagnósticos

O foco principal é restaurar a arquitetura do sono para prevenir o desenvolvimento de comorbidades severas. A má qualidade do sono não é apenas um sintoma, mas um gatilho para quadros de depressão, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, além de representar um risco iminente de acidentes devido à sonolência excessiva.

Diretrizes de tratamento: O plano terapêutico é multidisciplinar e personalizado conforme o diagnóstico:

Intervenções clínicas: Utilização de dispositivos de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) para o tratamento de apneia obstrutiva.

Psicoterapia e educação: Aplicação de Terapia Cognitivo-Comportamental e protocolos de higiene do sono para reeducação do descanso.

Suporte farmacológico: Uso criterioso de medicação quando as abordagens comportamentais não forem suficientes.

2.2 Indicações clínicas e critérios de acesso

Distúrbios do sono: apneia presenciada, roncos, sonolência excessiva.

Observação: Não encaminhar pacientes com distúrbios do sono não respiratórios (SES/SC.a, 2024).

É importante considerar na abordagem inicial do paciente a idade, índice de massa corporal, presença ou não de doenças associadas, medicações em uso.

Informar laudo de exames já realizados: polissonografia.



2.3 Profissionais requisitantes

Médicos da atenção primária e médicos de outras especialidades

2.4 Requisitos mínimos para o encaminhamento

O médico solicitante deve obrigatoriamente informar no sistema de regulação:

1. Quadro Clínico: Descrição detalhada de sinais, sintomas e achados do exame físico.
2. Dados Antropométricos.
3. Farmacoterapia: Listar medicamentos em uso e descrever tratamentos prévios realizados para a queixa atual.
4. Informar laudo de exames já realizados.
5. Segurança do Paciente: Relatar comorbidades, alergias medicamentosas e histórico de reações a anestésicos.

Tabela 01 - Tabela de conferência para encaminhamento para medicina do sono (checklist obrigatório)

Itens de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a regulação
Sinais de alarme	Saturação de oxigênio (O2) menor 90% (obesos mórbidos), cardiopatias graves.	Determinar a classificação Vermelha.
Tratamento prévio	Droga utilizada, dose e tempo de uso (mínimo 8 semanas).	Evitar exames desnecessários em casos de subdosagem.
Perfil de risco	Idade, índice de massa corporal (IMC), comorbidades e uso de medicamentos.	Para definir se o exame será ambulatorial ou hospitalar.
Alergias	Histórico de reações a anestésicos ou medicamentos.	Garantir a segurança durante a sedação

Elaborado por: Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos (NGQP), 2026.



2.5 Matriz de estratificação de risco para medicina do sono

Tabela 02 - Matriz de estratificação de risco para medicina do sono

Classificação	Critérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Pacientes aguardando cirurgias seja bariátrica, ortognática, cardiológica ou otorrinolaringológica, distrofias musculares sintomáticos que não estão usando bipap, pacientes com obesidade mórbida que já apresentam dessaturação (sat O2 menor 90%) acordados, pacientes cardiopatas graves.
AMARELO	Obesidade mórbida com sinais de apneia grave ou hipoventilação à polissonografia (índice de apneia > 30/hora e dessaturação durante a noite).
VERDE	Pacientes obesos.
AZUL	Demais casos.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC).a, 2024.

ATENÇÃO!

PARA USUÁRIOS SEREM ENCAMINHADOS A ESPECIALIDADE MEDICINA DO SONO, DEVEM DISPOR DO LAUDO DE POLISSONOGRAFIA.

3.INFORMAÇÕES REFERENTE AO EXAME DE POLISSONOGRAFIA

É um exame não invasivo que monitora diversas funções corporais durante o sono para diagnosticar distúrbios como apneia, ronco, insônia e síndrome das pernas inquietas, registrando atividade cerebral, cardíaca, respiratória, movimentos oculares e níveis de oxigênio através de sensores, podendo ser feita em clínicas ou em casa.

3.1 Objetivos clínicos e diagnósticos

Estudar o sono, analisando padrões fisiológicos e comportamentais noturnos.

Diagnóstico: Ajuda a identificar condições como ronco, apneia do sono, bruxismo, sonambulismo e alterações de ritmo cardíaco.

3.2 Critérios de emergência

A busca por emergência é necessária se o paciente apresentar ronco alto acompanhado de pausas respiratórias, sonolência diurna extrema (dormir dirigindo ou comendo), cefaleia matinal intensa ou aumento repentino da pressão arterial.

3.3 Indicações clínicas e critérios de acesso

Consiste em um exame que avalia diversas funções corporais durante o sono e serve como ferramenta para o diagnóstico da apnéia do sono, roncos excessivos, insônia, narcolepsia dentre outras patologias associados ao padrão de sono (DUARTE et al, 2022).

Usuários portadores de um ou mais sintomas abaixo, possuem indicação para realizar o exame:

- Apneia presenciada;
- Roncos;
- Sonolência excessiva.

Destaca-se que o exame será primeiramente avaliado pelo médico da APS e de acordo com o resultado será incluído no encaminhamento à Medicina do Sono para o médico regulador, da secretaria da saúde de Joinville, incluí-lo-á no SISREG, seguindo



critérios de gravidade e prioridade definidos neste documento, para a especialidade médica.

IMPORTANTE

Paciente em uso de CPAP só tem indicação de repetir a polissonografia em caso de dificuldade de adaptação ou após alguma intervenção significativa como cirurgia ortognática ou bariátrica ou grande perda de peso e, portanto, devem agendar consulta com Medicina do Sono antes do agendamento de nova polissonografia.

3.4 Profissionais requisitantes

Médicos da atenção primária e médicos de outras especialidades.

3.5 Requisitos mínimos para o encaminhamento

Para que a regulação ocorra de forma eficiente, o médico solicitante deve registrar:

1. Quadro Clínico: Descrição detalhada de sinais, sintomas e achados do exame físico;
2. Dados Antropométricos, especialmente o IMC;
3. Listar medicamentos em uso e descrever tratamentos prévios realizados para a queixa atual;
4. Presença ou não de doenças associadas;
5. Informar laudo de exames já realizados;
6. Relatar comorbidades, alergias medicamentosas e histórico de reações a anestésicos.

Tabela 03 - Tabela de conferência para encaminhamento para exame de polissonografia (checklist obrigatório)

Itens de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a regulação
Sinais de Alarme	Saturação de O2 menor 90% (obesos mórbidos), cardiopatias graves.	Determinar a classificação Vermelha.
Perfil de Risco	Idade, IMC, comorbidades	Definir se o exame será



	e uso de medicamentos.	ambulatorial ou hospitalar.
Alergias	Histórico de reações a anestésicos ou medicamentos.	Garantir a segurança durante a sedação se indicado.

Elaborado por: NGQP,2026.

3.6 Matriz de estratificação de risco para exame de polissonografia

Tabela 04 - Matriz de estratificação de risco para medicina do sono

Classificação	Crítérios de indicação e gravidade
VERMELHO	Pacientes aguardando cirurgias seja bariátrica, ortognática, cardiológica ou otorrinolaringológica, distrofias musculares sintomáticos que não estão usando bipap, pacientes com obesidade mórbida que já apresentam dessaturação (sat O2 menor 90%) acordados, pacientes cardiopatas graves.
AMARELO	Obesidade mórbida com sinais de apneia grave ou hipoventilação à polissonografia (índice de apneia > 30/hora e dessaturação durante a noite).
VERDE	Pacientes obesos.
AZUL	Demais casos.

Fonte: SES/SC.b, 2024.



REFERÊNCIAS

DUARTE, Ricardo Luiz de Menezes et al. Consenso em Distúrbios Respiratórios do Sono da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 48, n. 4, e20220232, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.36416/1806-3756/e20220232>. Acesso em: 26 jan. 2026.

FONSECA, Lorena Barbosa de Moraes; SILVEIRA, Erika Aparecida; LIMA, Nathalia Meireles; RABAHI, Marcelo Fouad. Tradução e adaptação transcultural do questionário STOP-Bang para a língua portuguesa falada no Brasil. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 42, n. 4, p. 266-272, jul./ago. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37562015000000243>. Acesso em: 30 jan. 2026.

HUYETT, Phillip; BHATTACHARYYA, Neil. Incremental health care utilization and expenditures for sleep disorders in the United States. **Journal of Clinical Sleep Medicine**, v. 17, n. 10, p. 1981-1986, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5664/jcsm.9392>. Acesso em: 26 jan. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Protocolo da Medicina do Sono do Estado de Santa Catarina**. Florianópolis: SES/SC, 2024a. Disponível em: <https://share.google/LFs2AMiac1OCPstgn>. Acesso em: 26 jan. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Protocolo de Polissonografia do estado de Santa Catarina**. Florianópolis: SES/SC, 2024b. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/regulacao/protocolo-de-acesso-e-classificacao-d-e-risco/polissonografia-exames/download>. Acesso em: 26 jan. 2026.



ANEXO A - STOP-BANG

Roncos? Você ronca alto (alto o suficiente que pode ser ouvido através de portas fechadas ou seu companheiro cutuca você à noite para parar de roncar) ?	
Sim ()	Não ()
Cansado? Você frequentemente se sente cansado, exausto ou sonolento durante o dia (como, por exemplo, adormecer enquanto dirige)?	
Sim ()	Não ()
Observou? Alguém observou que você para de respirar ou engasga/fica ofegante durante o seu sono?	
Sim ()	Não ()
Pressão? Você tem ou está sendo tratado para pressão sanguínea alta?	
Sim ()	Não ()
Índice de massa corporal maior que 35 kg/m²?	
Sim ()	Não ()
Idade acima de 50 anos?	
Sim ()	Não ()
O pescoço é grosso? (Medida em volta do pomo de Adão) Para homens, o colarinho da sua camisa é de 43 cm ou mais? Para mulheres, o colarinho da sua camisa é de 41 cm ou mais?	
Sim ()	Não ()
Sexo = Masculino?	
Sim ()	Não ()
Critérios de Pontuação: Para a população geral Baixo risco de AOS (apneia obstrutiva do sono): Sim para 0 a 2 perguntas Risco intermediário de AOS: Sim para 3 a 4 perguntas Risco alto de AOS: Sim para 5 a 8 perguntas OU Sim para 2 ou mais das 4 perguntas iniciais + sexo masculino OU Sim para 2 ou mais das 4 perguntas iniciais + IMC > 35 kg/m² OU Sim para 2 ou mais das 4 perguntas iniciais + circunferência do pescoço (43 cm em homens, 41 cm em mulheres)	

Fonte: FONSECA et al., 2016.

